INSTRUMENTUL 4 / 5

Planificator Clinic în 4 Etape

Diagnostic → Obiective → Mecanică → Control. Fișă de planificare printabilă, de completat manual pentru fiecare caz.

Manualul Ortodontului

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Cum să folosești Planificatorul?

Pentru fiecare caz nou, printează fișa și păstreaz-o în dosarul pacientului.

Planul derivă din lista de probleme. Întâi diagnosticul, apoi obiectivele, la final mecanica. Dacă inversezi ordinea, tratamentul se va prelungi.

1. **Pasul 1 · Diagnostic** – Completează datele despre profil, ocluzie, analiza spațiului, cefalometrie și radiografia panoramică (OPG). Pentru OPG folosește Instrumentul 1, pentru clasificare folosește Instrumentul 3. La final, notează lista de probleme în ordinea priorității.

2. **Pasul 2 · Obiective** – Pentru fiecare problemă, scrie un obiectiv: profil, finalizarea pe molari și canini, overjet, overbite, linie mediană. Decide extracția cu Instrumentul 2; stabilește aici necesarul de ancoraj.

3. **Pasul 3 · Secvența mecanică** – Scrie ordinea în care atingi obiectivele. Fiecare etapă are arcul sau aparatul auxiliar corespunzător. Bifează ce ai finalizat.

4. **Pasul 4 · Control și finalizare** – OPG intermediară, repoziționarea bracketurilor, cele 6 chei ale ocluziei și planul de contenție. Înainte de debracketare, toate rândurile trebuie să fie bifate.

Regulă

Un rând rămas gol reprezintă o decizie neasumată. Înainte de colarea bracketurilor, pașii 1 și 2 trebuie să fie complet; ulterior, folosește Instrumentul 5 pentru verificarea finală.

Greșeală frecventă

Să scrii secvența mecanică din obișnuință. Întâi corecția transversală și ortopedică, apoi alinierea; până nu este deschisă ocluzia adâncă, nu poți trece la corecția sagitală.

Căsuțe

Bifează opțiunea corectă; dacă nu este în listă, scrie la finalul rândului.

Modificare

Dacă planul se schimbă, taie rândul vechi și notează data și noua decizie alături.

PLANIFICATOR · PAGINA 1

Pasul 1 • Diagnostic

Nu trece la pasul 2 până nu ai toată documentația completă.

Pacient / vârstă / dată	
Motivul prezentării	
Obicei vicios	☐ Suptul degetului ☐ Respirație orală ☐ Interpoziție linguală ☐ Bruxism

Profil și față

Profil	☐ Drept ☐ Convex ☐ Concav
Buze	☐ Laxe ☐ Tensionate ☐ Protruzive ☐ Retruzive
Linie mediană facială / menton	
Zâmbet	☐ Zâmbet gingival ☐ Coridoare bucale largi ☐ Normal

Ocluzie

Molari / canini (dreapta · stânga)	
Overjet / overbite (mm)	
Linie mediană maxilar / mandibulă (mm)	
Ocluzie inversă / în foarfecă	
Curba Spee	☐ Plată ☐ Medie ☐ Adâncă
Diferență funcțională (RC–IM)	☐ Nu există ☐ Există: ____ mm
ATM	☐ Fără semne ☐ Zgomote ☐ Durere ☐ Deschidere limitată

Spațiu, cefalometrie și documentație

Necesar de spațiu maxilar / mandibular (mm)	
Analiză Bolton	☐ Proporțional ☐ Exces maxilar ☐ Exces mandibular
SNA / SNB / ANB · Wits	
FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN	
Panoramic (Instrumentul 1)	☐ Negativ ☐ Există diagnostic →
Parodonțiu / biotip	☐ Gros ☐ Subțire ☐ Prezență recesiune
Stadiu de creștere	☐ Pre-puseu ☐ În puseu ☐ Finalizat
Diagnostic diferențial (Instrumentul 3)	☐ Dentar ☐ Osos ☐ Pseudo

Listă probleme (în ordinea priorității)

PLANIFICATOR · PAGINA 2

Pasul 2 · Obiective

Fiecare problemă necesită un obiectiv. Obiectivul trebuie să fie măsurabil.

Obiectiv facial	☐ Menținere profil ☐ Reducere suport labial ☐ Creștere suport labial
Finalizare molară dreapta / stânga	☐ Clasa I ☐ Clasa II completă ☐ Clasa III completă
Finalizare canină	☐ Clasa I
Obiectiv overjet / overbite (mm)	
Linie mediană	☐ Corectare ☐ Acceptare
Poziție incisivi	☐ Menținere ☐ Retracție ☐ Proclinare controlată
Transversal	☐ Nu necesită ☐ RME ☐ Expansiune dentoalveolară
Vertical	☐ Menținere ☐ Deschidere ocluzie adâncă ☐ Închidere ocluzie deschisă
Decizie extracție (Instrumentul 2)	☐ Fără extracții ☐ Extracție: _____
Nevoie de ancoraj	☐ Minim ☐ Mediu ☐ Maxim
Dispozitiv de ancoraj	☐ TPA ☐ Arc Nance ☐ Mini-implant ☐ Elastice

Limite acceptate / compromisuri

Explicat pacientului	☐ Opțiuni ☐ Durată ☐ Contenție

PLANIFICATOR · PAGINA 3

Pasul 3 · Secvență mecanică

Notează secvența, bifează ce este finalizat. Nu trece la pasul următor până nu îl finalizezi pe cel curent.

✓	PAS	ARC / APARAT / ACCESORIU	DATA ÎNCEPERII
☐	Ortopedie / expansiune		
☐	Nivelare și aliniere		
☐	Ocluzie adâncă / Curba Spee		
☐	Închiderea spațiilor		
☐	Corecție sagitală		
☐	Linia mediană		
☐	Finisare (torque, rotație)		

Pasul 4 · Control și Finalizare

Frecvența controalelor

Radiografie panoramică intermediară (paralelism radicular) ☐ Planificat ☐ Efectuat

Repoziționarea bracket-urilor ☐ Nu este necesar ☐ Dinți: _____

Cele 6 chei ale ocluziei ☐ Molar ☐ Angularea coroanei ☐ Înclinarea coroanei ☐ Rotație ☐ Contact ☐ Plan de ocluzie

Overjet / overbite / linie mediană ☐ La valoarea țintă

Contenție maxilar ☐ Lingual fix ☐ Hawley ☐ Essix

Contenție mandibulă ☐ Lingual fix ☐ Hawley ☐ Essix

Risc de recidivă / notițe

EXEMPLU

Exemplu Completat

Caz ipotetic. Pentru cazul tău, este suficient să scrii cu același nivel de detaliu.

1 · DIAGNOSTIC

Pacient	*Fată de 13 ani. Acuză: „Dinții de sus sunt prea în față."*
Profil	*Profil convex, retrognatism mandibular; închidere labială forțată*
Ocluzie	*Clasa II molară și canină bilateral; overjet 8 mm, overbite 5 mm; curba Spee accentuată*
Spațiu / Bolton	*Înghesuire de 2 mm sus, 3 mm jos; Bolton proporționat*
Cefalometrie	*SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA 97°*
Altele	*OPG negativ; biotip gros; în puseu de creștere; fără derapaje*
Diagnostic (Instrumentul 3)	*Clasa II/1 scheletală, retrognatism mandibular; profilul se îmbunătățește în ocluzie constructivă*
Lista de probleme	*1) Sagitală (overjet) 2) Ocluzie adâncă 3) Înghesuire ușoară 4) Incompetență labială*

2 · OBIECTIVE

Profil / sagital	*Avansarea mandibulei; Clasa I molară și canină*
Overjet / overbite	*2–3 mm / 2–3 mm*
Extracție / ancoraj	*Fără extracții (Instrumentul 2: incisivii inferiori sunt deja proclinați, de urmărit); ancoraj mediu*
Explicații pentru pacient	*Purtarea aparatului funcțional, două etape, durata contenției*

3 · SECVENȚA MECANICĂ

1. Ortopedie	*Twin Block; control regulat al purtării*
2. Aliniere	*Trecerea la aparat fix: secvență NiTi → oțel*
3. Ocluzie adâncă	*Corecția curbei Spee, intruzie frontală*
4. Finisare	*Elastice de Clasa II ușoare dacă este necesar; torque și rotație*

4 · CONTROL ȘI FINALIZARE

Controale	*La intervale regulate; paralelism radicular pe OPG intermediar*
Finalizare	*Verificarea celor 6 chei; overjet și overbite la valoarea țintă*
Contenție	*Essix sus, lingual fix jos; risc de recidivă: proclinația incisivilor inferiori*

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului sau avizul specialistului.

Pasul următor

Dacă ai completat foaia, înainte de colarea bracketurilor rulează planul cu ajutorul **Instrumentul 5 · Radarul Erorilor de Planificare**. Întreaga logică a planificării se află în capitolul **Modulul 03 · Planificarea Clinică: de la Lista de Probleme la Mecanică**.